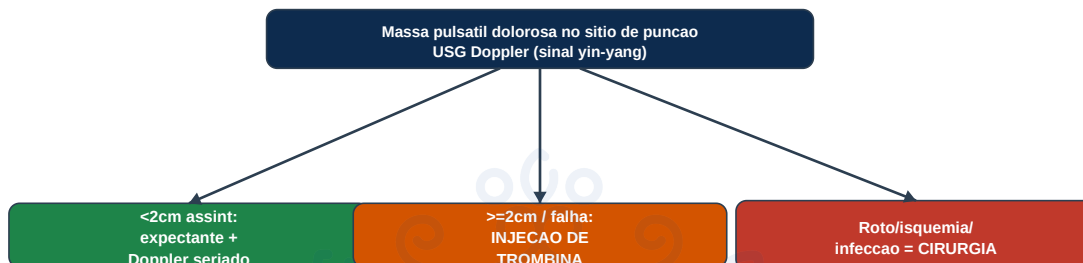


PSEUDOANEURISMA — PÓS-PUNÇÃO ARTERIAL

FLUXOGRAMA — MASSA PULSÁTIL PÓS-PUNÇÃO

PSEUDOANEURISMA — TAMANHO E SINTOMAS GUIAM



DEFINIÇÃO E CAUSAS

O QUE É

- Coleção pulsátil de sangue FORA da parede arterial, contida por tecidos adjacentes (não tem as 3 camadas)
- Causa mais comum: punção arterial (cateterismo coronário/angiografia, femoral/radial)
- Outras: punções repetidas, anticoagulantes/antiagregantes, trauma vascular, infecção (raro)
- Difere do aneurisma verdadeiro (que mantém a parede arterial dilatada)

QUADRO CLÍNICO

QUANDO SUSPEITAR

- Massa pulsátil dolorosa no local da punção
- Sopros à ausculta; hematoma de aumento progressivo
- Dor local ou irradiada
- Sinais de complicação: isquemia distal, compressão nervosa, sangramento ativo
- Instabilidade hemodinâmica é rara (mas possível em rotura)

DIAGNÓSTICO E CLASSIFICAÇÃO

DIAGNÓSTICO

- Exame de escolha: USG DOPPLER
- Sinal do 'yin-yang' (fluxo bidirecional)
- Avaliar o COLO do pseudoaneurisma e o tamanho
- Complementares: AngioTC (casos complexos), arteriografia (planejamento)

CLASSIFICAÇÃO (prática)

- Pequeno: < 2 cm
- Médio: 2-4 cm
- Grande: > 4 cm
- Complicado: infecção, crescimento rápido, isquemia ou ruptura

CONDUTA TERAPÊUTICA

Opção	Indicação	Observação
Expectante	< 2 cm, assintomático, estável, sem anticoagulação plena	Repouso, compressão, Doppler seriado 7-14 dias
Compressão guiada por USG	2-4 cm, sintomático leve, colo estreito	Contra: dor intensa, infecção, grande
Injeção de trombina	>= 2 cm, falha da compressão, em anticoagulado, colo definido	ESCOLHA: sucesso >95%, rápido, minimamente invasivo
Cirurgia	Roto, crescimento rápido, isquemia, compressão neuro, infecção, falha percutânea	Reparo aberto

INJEÇÃO DE TROMBINA — TRATAMENTO DE ESCOLHA

PONTOS-CHAVE

- Alta taxa de sucesso (>95%), procedimento rápido e minimamente invasivo
- Indicada para pseudoaneurismas >= 2 cm, com colo bem definido, sobretudo em anticoagulados
- Contraindicações: infecção, comunicação arteriovenosa associada, alergia conhecida à trombina
- Guiada por USG, injetando no saco (não no colo) para trombosar

RED FLAGS — INDICAÇÃO CIRÚRGICA

NÃO TENTAR PERCUTÂNEO SE

- Pseudoaneurisma ROTO ou com sangramento ativo / instabilidade
- Crescimento rápido
- Isquemia distal (monitorar pulsos)
- Compressão neurológica (déficit motor/sensitivo)
- Infecção local (pseudoaneurisma micótico)

CUIDADOS E SEGUIMENTO

NÃO ESQUECER

- ☐ Revisar/ajustar anticoagulação e antiagregação
- ☐ Analgesia adequada e monitorização dos pulsos distais
- ☐ Curativo compressivo pós-procedimento
- ☐ USG Doppler de controle conforme protocolo institucional
- ☐ Orientar sinais de alerta: aumento da massa, dor intensa, sangramento

MODELO DE REGULAÇÃO / TRANSFERÊNCIA

RESUMO PARA REGULAÇÃO

- Paciente com pseudoaneurisma ____ (sítio: femoral/radial) de ____ cm, pós-punção, anticoagulado: sim/não.
- USG Doppler: yin-yang, colo ____; complicações: isquemia/compressão/infecção/rotura.
- Conduta proposta: expectante / compressão / injeção de trombina / cirurgia.
- Solicito avaliação da cirurgia vascular / hemodinâmica para tratamento definitivo.

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

USP-SP / Adaptada

Paciente pós-cateterismo femoral com massa pulsátil dolorosa de 3 cm, em uso de dupla antiagregação, colo bem definido ao Doppler. Qual o tratamento de escolha?

- A) Cirurgia aberta imediata
- B) Injeção de trombina guiada por ultrassom
- C) Apenas observação por 30 dias
- D) Anticoagulação plena
- E) Compressão manual por 5 minutos

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Qual é o exame de escolha para o diagnóstico do pseudoaneurisma arterial?

- A) Radiografia
- B) Ultrassonografia com Doppler (sinal do yin-yang)
- C) Ressonância sem contraste
- D) Cintilografia
- E) Tomografia sem contraste

QUESTÃO 3

SES-DF / Adaptada

Qual situação contraindica a injeção de trombina e indica tratamento cirúrgico?

- A) Pseudoaneurisma de 2,5 cm assintomático
- B) Infecção local, ruptura, isquemia distal ou compressão neurológica
- C) Uso de anticoagulante
- D) Colo bem definido
- E) Paciente idoso

QUESTÃO 4

UNIFESP / Adaptada

Pseudoaneurisma de 1,5 cm, assintomático, paciente estável e sem anticoagulação plena. Conduta inicial adequada?

- A) Cirurgia imediata
- B) Conduta expectante com repouso, compressão e Doppler seriado
- C) Injeção de trombina obrigatória
- D) Amputação
- E) Trombólise sistêmica

QUESTÃO 5

UFRJ / Adaptada

Qual a principal causa de pseudoaneurisma arterial na prática hospitalar?

- A) Aterosclerose
- B) Punção arterial (cateterismo/angiografia)
- C) Hipertensão isolada
- D) Diabetes
- E) Vasculite

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

Pseudoaneurisma ≥ 2 cm, com colo definido, especialmente em anticoagulado, tem como tratamento de escolha a injeção de trombina guiada por USG (sucesso $>95\%$, rápido e minimamente invasivo).

QUESTÃO 2 → Resposta: B

O USG Doppler é o exame de escolha: demonstra o sinal do 'yin-yang' (fluxo bidirecional no saco), avalia o colo e o tamanho, orientando a conduta.

QUESTÃO 3 → Resposta: B

Infecção, ruptura, isquemia distal e compressão neurológica são indicações de cirurgia e contraindicam/superam o tratamento percutâneo (trombina). Anticoagulação e colo definido, ao contrário, favorecem a trombina.

QUESTÃO 4 → Resposta: B

Pseudoaneurisma < 2 cm, assintomático, estável e sem anticoagulação plena pode ser manejado de forma expectante: repouso, compressão e Doppler seriado (muitos trombosam espontaneamente).

QUESTÃO 5 → Resposta: B

A causa mais comum de pseudoaneurisma é a punção arterial (cateterismo/angiografia, tipicamente femoral), favorecida por punções repetidas e uso de anticoagulantes/antiagregantes.

SM24
Suporte ao Plantão Médico